

Twój pełny raport PEWA™

Typ: **Analitik (A)**

Supermoc — głęboka precyzja

Sekcja 1 — Kim jesteś (profil rozszerzony)

Twój dominujący archetyp to **Analitik** — racjonalny słuchacz, dla którego dane, fakty i precyzja są walutą. Twoje pierwsze pytanie w trudnej sytuacji to „co dokładnie wiemy?”. Twoje drugie: „co możemy sprawdzić?”. Twoje trzecie: „jakie jest prawdopodobieństwo X?”.

Tam, gdzie inni działają na intuicji, Ty masz wbudowany filtr trzeźwego myślenia. Pacjent, który trafia do Twojej praktyki, dostaje coś, czego wielu mu nie da: **diagnostykę bez emocji**. To nie znaczy, że jesteś chłodny — znaczy, że emocje nie zaciemniają Twojego osądu klinicznego.

Twoja siła to **wiarygodność**. Wiesz, co mówisz. Sprawdzasz przed wydaniem opinii. Nie obiecujesz tego, czego nie możesz dotrzymać. Z czasem to buduje **markę eksperta** — pacjenci wiedzą, że u Ciebie nie ma zgadywania.

W długiej perspektywie Twoja praktyka osiąga lepsze wyniki kliniczne niż średnia — bo Ty nie pomijasz badań, nie skrucasz protokołów, nie podejmujesz decyzji „bo intuicja”. Ta solidność jest Twoją supermocą.

Twoja supermoc w jednym zdaniu: *Wiesz to, co inni domyślają się — i podejmujesz decyzje na faktach, których inni nie sprawdzili.*

Co Cię energizuje: głębokie analizy, dobre dane, kompetentni rozmówcy, cisza do myślenia, jasne kryteria, długoterminowe projekty, momenty kiedy analiza przyniosła ratującą decyzję, książki, badania, konferencje z konkretem.

Co Cię wyczerpuje: spotkania bez agendy, „burze mózgów” bez konkluzji, pochopne decyzje innych, emocjonalne dramy, presja czasowa na decyzję bez danych, powierzchowne rozmowy, ludzie którzy „wiedzą lepiej” bez podstaw.

Sekcja 2 — Twoja sygnatura komunikacyjna

Twoje zdania są przemyślane. Tempo równe. Język precyzyjny. Często zaczynasz od „według badań...”, „dane pokazują...”, „z mojego doświadczenia w X przypadkach...”. Ludzie wokół wiedzą, że jeśli Ty coś mówisz — sprawdziłeś to.

5 zdań, które wypowiadasz częściej niż inni

1. „Według danych...”
2. „Sprawdźmy to.”
3. „Mamy 3 opcje: A, B, C.”
4. „Ryzyko wynosi X%.”
5. „Daję sobie 24 godziny na decyzję.”

5 zdań, które rzadko wypowiadasz

1. „Czuję że...”
2. „Daj mi się tym poeksytować.”
3. „Idziemy na żywioł.”
4. „Może jakoś to wyjdzie.”
5. „Spróbujmy bez planu.”

Twoje narzędzia niewerbalne

- **Kontakt wzrokowy spokojny** — utrzymujesz go bez intensywności.
- **Postawa wyważona** — siedzisz wyprostowany, gestykulacja minimalna.
- **Pauzy długie** — myślisz zanim odpowiesz. Cisza Cię nie peszy.
- **Notowanie** — często masz notes / tablet, zapisujesz w trakcie rozmowy.
- **Dotyk minimalny** — uścisk dłoni standardowy, bez efekciarstwa.

Jak najlepiej do Ciebie trafia inny lekarz / szef

- **Dane przed decyzją** — pokaż wskaźniki, badania, źródła.
- **Czas na przemyślenie** — „Daję ci 48h na opinię”. Lepiej dla nas obu.
- **Spotkanie 1-na-1** — w grupie tracisz część precyzji.
- **Konkretne pytanie** — abstrakcyjne „co myślisz?” Cię irytuje. „Co myślisz o A vs B?” — super.
- **Uznanie za wnikliwość** — pochwała „bo dokładnie sprawdziłeś” działa lepiej niż „bo szybko”.

Sekcja 3 — Mocne strony rozszerzone

1. Głęboka analiza

Tam, gdzie inni widzą 1 wymiar problemu, Ty widzisz 5. **Użyj tego:** trudne diagnozy, drugie opinie, sprawy złożone. Bądź „lekarzem od trudnych przypadków” w swojej okolicy.

2. Wiarygodność w argumentach

Każde Twoje twierdzenie ma za sobą źródło. **Użyj tego:** w trudnych rozmowach z pacjentem / partnerem / NFZ Twoja siła to „według danych z 2023...”. Twardy fact-check przy każdej decyzji.

3. Spokój pod presją

W kryzysie inni panikują — Ty sięgasz po dane. **Użyj tego:** w sytuacjach SOR / decyzji finansowych pod presją / kryzysów PR. Jesteś osobą, która utrzymuje racjonalność, gdy wszyscy emocjonują.

4. Precyzja w dokumentacji

Twoja dokumentacja jest wzorcowa. **Użyj tego:** zostań osobą, która tworzy szablony i procedury dla zespołu. Twoja jakość staje się standardem praktyki.

5. Filtr trzeźwego myślenia

Inni dają się porwać entuzjazmem nowości — Ty pytasz „a ryzyko?”. **Użyj tego:** Ty jesteś osobą, która ocenia oferty dostawców / nowych technologii / partnerstw. Twoja praktyka oszczędza tysiące na nietrafionych inwestycjach.

6. Długoterminowa perspektywa

Tam, gdzie inni patrzą tydzień do przodu, Ty 12 miesięcy. **Użyj tego:** strategia rozwoju praktyki, długoterminowe relacje z pacjentem, plany leczenia rozłożone na lata.

7. Mistrzowska weryfikacja

Sprawdzasz to, czego inni nie sprawdzają. **Użyj tego:** w zespole bądź „ostatnim spojrzeniem” przed wysłaniem ważnego pisma / podpisaniem kontraktu / wystawieniem rachunku.

8. Naturalna ekspertyza

Z czasem stajesz się autorytetem w niszy. **Użyj tego:** wybierz 1 wąską specjalizację i bądź w niej najlepszy w regionie. Twoja precyzja Cię tam doprowadzi.

9. Spokojna komunikacja w trudnej diagnozie

Inni mówią pacjentowi diagnozę i pacjent się rozkleja. Ty komunikujesz tak, że pacjent rozumie i ma plan. **Użyj tego:** Ty informuj pacjentów o trudnych diagnozach (onkologia, choroby przewlekłe). Twoja struktura ich uspokaja.

10. Sprawność w sprawach prawnych / proceduralnych

NFZ, ZUS, kontrole — Twoja domena. **Użyj tego:** Ty zajmujesz się formalnymi pismami i sprawami z urzędami. Inni Cię za to pokochają.

Sekcja 4 — Naturalne wyzwania + pierwsza pomoc

Twoja precyzja ma swoją cenę: paraliż analizy, zbyt długie odkładanie decyzji, chłodny dystans, brak ciepła w trudnych momentach emocjonalnych. Oto 9 sytuacji.

1. Paraliż analizy

Sygnal wczesny: zbierasz dane od 3 tygodni i nadal nie decydujesz; szukasz „jeszcze jednej informacji”.

Pierwsza pomoc w 60 sek: - Zasada „80% wystarczy” — jeśli masz 80% danych i decyzja jest odwracalna, ACT. - Daj sobie deadline: *„Decyduję w piątek do 12:00, niezależnie od stanu wiedzy”*.

Plan długofalowy: ćwicz „decyzje 60 sekund” dla błahych spraw. Lunch, ubranie, mała inwestycja. Buduj „miesiąc decyzyjny”.

2. Pacjent emocjonalny — Twoja reakcja chłodna

Sygnal wczesny: pacjent płacze, Ty oferujesz fakt zamiast wsparcia („to typowe dla tego stadium choroby”).

Pierwsza pomoc: *„Słyszę że to dla Pana/Pani trudne. Daj mi minutę — jestem tu.”* — bez od razu danych.

Plan długofalowy: ucz się „warmup minute” — pierwsze 60 sekund każdej rozmowy poświęcasz na ciepło. Dopiero potem fakty.

3. Pacjent który chce „rozmawiać” zamiast otrzymywać dane

Sygnal wczesny: chcesz mu dać konkret w 2 minuty, on chce 30 minut rozmowy.

Pierwsza pomoc: zarezerwuj pacjentowi „wizytę długą” (45 min). W trakcie krótkiej (15 min) — nie próbuj go usatysfakcjonować emocjonalnie. To niemożliwe w 15 min.

Plan długofalowy: zatrudnij asystentkę typu P, która prowadzi „postwizytowe rozmowy”. Pacjent dostaje od Ciebie merytorykę, od niej ciepło.

4. Spotkanie z kolegą typu Entuzjasta (E)

Sygnal wczesny: jego pomysły Cię frustrują, chcesz mu wyliczyć 5 powodów dlaczego to nie zadziała.

Pierwsza pomoc: „Ciekawe. Daj mi 24 godziny na analizę i wracam z konkretem.” — szanujesz jego entuzjazm, ale dasz sobie czas.

Plan długofalowy: E i Ty się świetnie uzupełniacie. On generuje pomysły, Ty filtrujesz. Współpraca o ile Ty nie zabijasz każdego pomysłu na starcie.

5. Presja na szybką decyzję bez danych

Sygnal wczesny: szef / partner / pacjent oczekuje odpowiedzi „TERAZ”, Ty czujesz dyskomfort.

Pierwsza pomoc: „Daj mi 4 godziny / 24 godziny — wróć z rekomendacją popartą danymi”. Granica + termin + obietnica.

Plan długofalowy: zbuduj „bazę wiedzy” — najczęściej powracające pytania mają gotowe odpowiedzi. Wtedy „4 godziny” stają się „4 minuty”.

6. Kryzys w zespole — emocjonalny konflikt

Sygnal wczesny: chcesz zniknąć z pokoju, schronić się w danych.

Pierwsza pomoc: zostań fizycznie, ale przejmij rolę „moderatora faktów”. „Co dokładnie się stało? Wymieńcie po kolei.”

Plan długofalowy: ucz się rozpoznawać kiedy ludziom potrzeba „wysłuchania” (P), a kiedy „decyzji” (W). Twoja domena to faza po decyzji — sprawdzenie czy wszystko poszło ok.

7. Wystąpienie publiczne / prezentacja

Sygnal wczesny: w slajdach masz 200 wykresów, mowa będzie trwała 3× dłużej niż czas.

Pierwsza pomoc: zasada „1 slajd = 1 kluczowa myśl”. Maksymalnie 1 wykres na slajd. Reszta — backup.

Plan długofalowy: ucz się storytellingu od kogoś typu E. Twoja merytorykę + jego forma = wybitne wystąpienia.

8. Krytyka osobista

Sygnal wczesny: odbierasz krytykę jako atak na Twoją kompetencję; zaczynamy wyliczać dane na obronę.

Pierwsza pomoc: „Dziękuję. Daj mi 24 godziny na analizę.” — bez argumentacji w tej chwili.

Plan długofalowy: wprowadź dziennik krytyki. Po 3 miesiącach zobaczysz: które krytyki były słuszne, które nie.

9. Praca długimi godzinami nad detalem

Sygnal wczesny: „jeszcze tylko sprawdzę jedną rzecz” — i jest 22:00.

Pierwsza pomoc: ustal nieprzekraczalny czas wyjścia. Telefon dzwoni o 18:30 z pytaniem od kogoś bliskiego — to Twój alarm.

Plan długofalowy: wprowadź zasadę „good enough” dla rutynowych dokumentów. Tylko dla kluczowych decyzji idziesz do mistrzowskiej precyzji.

Sekcja 5 — Twoje duety w zespole

Z Przyjacielem (P)

Plus: Ty dane, on ciepło. Pacjent dostaje pełen serwis. **Ryzyko:** możesz odbierać jego emocjonalność jako brak profesjonalizmu. **Co robić:** otwórz rozmowę o stylach — niech wie, że Twój dystans to ochrona, nie obojętność.

Z Entuzjastą (E)

Plus: Jego pomysły + Twoja weryfikacja = mniej błędów. **Ryzyko:** Twoje pytania go hamują; on Twoją analizę odbiera jako brak energii. **Co robić:** ustal: on generuje, Ty filtrujesz — RAZEM po 24 godzinach decydujecie.

Z Wodzem (W) — idealny mózg

Plus: Ty analiza, on decyzja. Twoje 7 ratunków rocznie przed jego pochopną decyzją. **Ryzyko:** jego tempo Cię frustruje, on Twoje pytania odbiera jako hamulec. **Co robić:** wprowadź regułę „każda decyzja >10 000 zł — 24h na opinię A”.

Z drugim Analitykiem (A)

Plus: precyzja x2, świetne procedury, jakość dokumentacji. **Ryzyko:** paraliż analizy x2, nigdy nie podejmujecie decyzji. **Co robić:** ktoś musi mieć autorytet do „końca dyskusji”. Zaprosicie 3-ciego — typ W.

Idealny zespół 4-osobowy

A (Ty) + W + P + E — pełne pokrycie. Ty weryfikujesz, W decyduje, P stabilizuje, E rozkręca.

Sekcja 6 — Pacjenci których rozumiesz

Ten raport jest uniwersalny — dla lekarzy POZ, specjalistów, dentystów, pielęgniarek, asystentek, recepcjonistek. Każda profesja medyczna ma do czynienia z 4 typami pacjentów, ale **dentyści** mają tu dodatkowy bonus: w 800 testach przeprowadzonych przez Michała Katarzyńskiego w polskich praktykach stomatologicznych potwierdzono te same 4 typy z bardzo konkretnymi sygnałami.

Dla każdego z 4 typów pacjentów — **najpierw opis uniwersalny** (dla każdej specjalizacji), **potem rozszerzenie stomatologiczne** (z ebooka „Jak zaspokoić 7 podstawowych potrzeb pacjentów stomatologicznych”, 2017).

Typ pacjenta: PRZYJACIEL (relacyjny ciepły)

Opis uniwersalny

Pacjent szukający relacji. Otwiera się, opowiada o sobie, lojalny po pierwszej dobrej wizycie. Wymaga ciepła, czasu, poczucia, że jest „u siebie”. Z trudem przyjmuje krytykę.

Słowa, które wypowiada: *bliskość, ludzie, ciepło, uprzejmie, pomoc, łagodnie, delikatnie, miło, spokojnie, intymnie, bezpiecznie, czuje, opieka, dbanie, wsparcie*

Motywatory: poczucie bezpieczeństwa, empatia, dozowanie wrażeń, język opieki, stabilność **Czego nie lubi:** nagłych zmian, braku stabilności, twardości, pośpiechu

Rozszerzenie stomatologiczne (ebook, 800 testów)

- **Najbardziej lojalny typ** — najrzadziej zmienia dentystę, chce żeby leczył go zawsze ten sam lekarz.
- Wolno buduje relacje, nie jest otwarty na zmiany.
- Na początku **największy lęk** ze wszystkich typów — inwazyjne procedury powinny być odłożone na później jeśli nie pilne.
- Idealna chemia z lekarzem typu Przyjaciel; problem przy Wodzu („Proszę się nie obawiać” go odepchnie).
- **NIE mów:** „Proszę się niczego nie obawiać. Wszystko będzie dobrze.”
- **MÓW:** „Może Pan/Pani być spokojny/a. Zajmiemy się Pania/Panem odpowiednio. Posiadamy bardzo bezpieczne, skuteczne i komfortowe znieczulenia.”

Typ pacjenta: ENTUZJASTA (emocjonalny ekstrawertyk)

Opis uniwersalny

Pacjent z energią. Szybko mówi, szybko decyduje, szybko zmienia tematy. Wymaga atmosfery i widocznego efektu. Z trudem przyjmuje monotonię i długie procedury.

Słowa, które wypowiada: *fantastycznie, super, emocjonujący, efektowny, rewelacja*

Motywatory: dobra atmosfera, komplementy, wizualizacja efektu, szybka zmiana
Czego nie lubi: odrzucenia, negacji, ignorowania, długiego leczenia bez efektów

Rozszerzenie stomatologiczne (ebook, 800 testów)

- Łatwo rozpoznać już na pierwszej wizycie: uśmiecha się, otwiera, szybko skraca dystans (uścisk dłoni, poklepywanie, przytulanie).
- Mówi szybko, wpada w słowotok, przeskakuje z tematu na temat.
- **Szybko podejmuje decyzję** o planie leczenia, ale **niecierpliwy** — chce wszystko „tu i teraz”.
- Wzrokowiec — pokaż obraz/zdjęcie najpierw, potem omawiaj.
- **Ryzyko:** brak ciągłości jeśli leczenie długie bez szybkich efektów. Spisz harmonogram, bo nie dosłyszysz mówiąc sam.
- **MÓW:** „Bardzo dobrze, że Pani/Pan przyszła do gabinetu. Świetnie, że zdecydował(a) się Pani/Pan kontynuować leczenie. Proszę zobaczyć jak idealny efekt został osiągnięty.”

Typ pacjenta: WÓDZ (racjonalny ekstrawertyk)

Opis uniwersalny

Pacjent zorientowany na wynik. Chce konkretnego, planu, najwyższej jakości. Szybko decyduje na racjonalnych przesłankach. Z trudem przyjmuje brak kontroli.

Słowa, które wypowiada: *cel, osiągnięcia, realizacja, natychmiast, zdecydowanie, absolutnie, strategia, taktyka, ambitnie, szybko, odpowiedzialność, zysk, korzyści, sukces, najlepiej, najlepszy*

Motywatory: najwyższa jakość, najlepszy lekarz, kontrola decyzji, „naj...”, racjonalne argumenty
Czego nie lubi: utraty kontroli, braku decyzji, krytyki, spóźnień, lekceważenia

Rozszerzenie stomatologiczne (ebook, 800 testów)

- 80% szefów największych firm z listy Fortune 500 to Wodzowie — to najbardziej wymagający typ pacjenta, często nazywany roszczeniowym.

- **Najmniej lojalny** typ — zmieni gabinet jeśli poczuje brak najwyższej jakości. Łatwo przekazuje negatywne uwagi (recenzje).
- Potrafi wymusić własną koncepcję leczenia, oczekuje wysokich rabatów (próbując rywalizować).
- Spóźnienia z Twojej strony = **ostentacyjnie wyjdzie z poczekalni**.
- ALE jeśli dobrze prowadzony — doprowadzi leczenie do końca bez względu na uciążliwość.
- **MÓW**: „*Proponuję najnowszą metodę X — to standard u liderów. Plan: krok 1 dziś, krok 2 za tydzień, krok 3 za miesiąc. Decyzja należy do Pana.*”

Typ pacjenta: ANALITYK (racjonalny introwertyk)

Opis uniwersalny

Pacjent pre-przygotowany. Przyszedł z pre-diagnozą, ma listę pytań, lubi schematy. Wymaga czasu na decyzję i precyzyjnych odpowiedzi. Z trudem przyjmuje pośpiech i chaos.

Słowa, które wypowiada: *dokładnie, krok po kroku, dane, informacje, uważnie, sumiennie, wykresy, statystyki, struktura, badania, analizy, procedury, ewentualne, przemyślane, wiarygodne, miarodajne, jakość*

Motywatory: jakość i dokładność, decyzja bez presji, dużo informacji, specjalistyczne procedury, przestrzeń na pytania **Czego nie lubi:** pośpiechu, chaosu, wielozadaniowości, braku informacji

Rozszerzenie stomatologiczne (ebook, 800 testów)

- **Sprawdził Twoją stronę PRZED wizytą**, przeczytał referencje konkretnego lekarza, przyszedł z pre-diagnozą.
- Lubi schematy, ciąg logiczny, standardy.
- Po przedstawieniu planu mówi „*Muszę się zastanowić*” lub „*Muszę to przeanalizować*” — to **normalne**, nie odmowa. Proces decyzyjny jest po prostu dłuższy.
- Lepiej zada pytania w gabinecie niż wyjdzie i nakręci się internecie.
- Analitykami są w dużej części **endodonci** i **chirurdzy**.
- **MÓW**: „*Zastosuję mikroskop, który zapewni większą dokładność. Według metaanalizy z 2023 — w 78% przypadków podobnych do Pana, leczenie X daje efekt Y. Jakie ma Pan pytania?*”

Matryca chemii — lekarz × pacjent

Lekarz Pacjent	Przyjaciół	Entuzjasta	Wódz	Analitik
Przyjaciół	idealna chemia	dobrze, uważaj na chaos	Wódz Cię zdominuje	dystans, ale możliwe
Entuzjasta	ciepło + energia	chemia, ale chaos x2	napęd	Twoja energia go przerazi
Wódz	pacjent się zdominuje	tempo OK	pełna zgoda	wspólna racjonalność
Analitik	ciepło z faktami	Twój dystans zdezorientuje	wspólne dane	idealna chemia

Sekcja 7 — Plan rozwoju 30 dni

Tydzień 1 — Decyzyjność

Dzień	Zadanie
1-2	Wybierz 3 decyzje które odkładasz. Wyznacz deadline dla każdej.
3-7	Codziennie podejmuj 1 „decyzję 60 sek” w błażej sprawie.

Tydzień 2 — Ciepło

Dzień	Zadanie
8-10	„Warmup minute” — pierwsze 60 sek każdej wizyty na ciepło.
11-14	Po każdym pacjencie zanotuj: co go ucieszyło?

Tydzień 3 — Działanie

Dzień	Zadanie
15-17	Wybierz 1 projekt który analizujesz od dawna. Zaczynij robić.
18-21	Codziennie 1 krok do przodu. Zero analizy.

Tydzień 4 — Integracja

Dzień	Zadanie
22-26	Wybierz 1 ćwiczenie z tygodni 1-3, robisz codziennie.
27-30	Rozmowa z bliskim/kolegą: co zauważyli innego?

Sekcja 8 — Plan rozwoju 90 dni

Miesiąc 2 — Komunikacja

- **Tydzień 5-6:** Mentoring od typu P — naucz się ciepłej komunikacji.
- **Tydzień 7-8:** 1 wystąpienie publiczne — konferencja, szkolenie, podcast.
- **Lektura:** „*Made to stick*” — Chip Heath.

Miesiąc 3 — Liderzy

- **Tydzień 9-10:** Wprowadź 1 procedurę dla całego zespołu jako Twoją sygnaturę.
- **Tydzień 11:** Trudna decyzja delegowana — Twoja analiza, ich decyzja.
- **Tydzień 12:** Retest PEWA.

Sekcja 9 — Twój wynik vs populacja

Grupa zawodowa	% typów A
Lekarze POZ	~21%
Pediatrzy	~17%
Psychiatrzy	~24%
Dentyści	~18%
Chirurdzy	~26%
Pielęgniarki	~13%
Recepcjonistki	~9%
Higienistki stomatologiczne	~15%
Asystentki	~11%
Menedżerowie praktyk	~16%

Wniosek: Analityk dominuje w specjalizacjach wymagających **precyzji diagnostycznej** (psychiatria, chirurgia, dentystryka, POZ z trudnymi przypadkami).

5 poziomów dojrzałości profilu Analityk

Poziom	Charakterystyka
1. Niedojrzały	Paraliż analizy, chłodny dystans, brak decyzyjności
2. Wczesny rozwój	Rozpoznaje potrzebę działania, próbuje deadline'ów
3. Stabilny	Decyduje na faktach, w rozsądnym czasie
4. Mistrzowski	Łączy precyzję z ciepłem, autorytet ekspercki
5. Mentorski	Uczy innych „decyzji 80%”, standard branżowy

Sekcja 10 — Materiały i termin retestu

Książki (5 pozycji)

1. „Pacjent musi czuć” — *Michał Katarzyński*.
2. „Thinking, fast and slow” — *Daniel Kahneman*. Twój manual.
3. „The signal and the noise” — *Nate Silver*. Decyzje pod niepewnością.
4. „Made to stick” — *Chip Heath*. Jak Analityk komunikuje ciekawie.
5. „Crucial conversations” — Trudne rozmowy bez dystansu.

Kursy (3 pozycje)

1. „Doskonała Obsługa Pacjenta” — Michał Katarzyński.
2. „Komunikacja medyczna” — Akademia Komunikacji.
3. „Statystyka dla lekarzy” — Coursera.

Podcasty (2)

1. „DOP w gabinecie” — Michał Katarzyński.
2. „Freakonomics” — Stephen Dubner.

Następny krok w Testomni

Test 2 — Wiedza lekarza (Twoja domena), lub Test 4 — Wszechstronne przywództwo.

Termin retestu: za 90 dni.